Edema

FISIOPATOLOGIA · Clase 02 · fuerzas de Starling alteradas: del capilar a la piel que se hunde

1 · QUÉ ES EL EDEMA Y CÓMO SE VE

Edema F5
líquido de más en el intersticio (extravascular) o dentro de las células

si es menor se llama → **Preedema** F5
menor de 5 litros o < 10 % del peso corporal

si pasa de 5 litros es → **Anasarca** F6
edema generalizado, más de 5 litros, con derrames en cavidades (pleura, pericardio, ascitis)

si es de una zona se llama → **Edema localizado** F7
TVP, linfedema, celulitis y esclavina (cuello, tórax, cara y brazos por obstrucción de la cava superior)

se reconoce por el → **Signo de la fóvea** F8
hoyo persistente al presionar sobre un plano óseo (tibia, sacro)

nace de las (Preedema, Anasarca)

2 · EL CAPILAR EN EQUILIBRIO: STARLING

Fuerzas de Starling F9
hidrostática saca el líquido; oncótica lo retiene; el linfático drena el exceso

normalmente mantienen el → **Equilibrio** F9
el líquido que sale vuelve al capilar y no se acumula

con retención hormonal da → 6 · RENAL: NEFRÓTICO Y NEFRÍTICO

si es de una zona produce / puede romperse por → 3 · LOS CINCO FACTORES QUE LO ROMPEN

3 · LOS CINCO FACTORES QUE LO ROMPEN

se rompe por uno de los

1 · **Hidrostática alta** F4
estasis venosa, insuficiencia cardiaca, TVP

y por

4 · **Oncótica intersticial alta** F9
el intersticio atrae agua (mixedema)

3 · **Permeabilidad alta** F9
inflamación y alergia: histamina y cininas

o por

5 · **Obstrucción linfática** F9
el líquido no se drena (linfedema)

se rompe también por

2 · **Oncótica plasmática baja** F1 · F2
carencial y nefrótico: pocas proteínas

su opuesto no produce edema: → **Trampa** F2
aumentar la oncótica plasmática nunca causa edema

en la vena obstruida se ve en la → 4 · CARDIACO Y ESTASIS VENOSA

en el hígado actúa por → 5 · HEPÁTICO: ASCITIS

en el riñón se ve en → 6 · RENAL: NEFRÓTICO Y NEFRÍTICO

en el hipotiroidismo da → 7 · OTROS EDEMAS Y COMPLICACIÓN

4 · CARDIACO Y ESTASIS VENOSA

TVP F17
tríada de Virchow: trombo que obstruye la vena y sube la presión local

Insuficiencia cardiaca F10
baja el débito y congestiona las venas

genera → **Congestión retrógrada** F10
sube la presión hidrostática y sale líquido al intersticio

en el corazón actúa por

al bajar el flujo renal activa → **Menor flujo renal** F10
activa el SRAA: retiene sodio y agua

retiene líquido y da → Edema maleolar continuo en cardiópatas

si el trombo se suelta causa → 7 · OTROS EDEMAS Y COMPLICACIÓN

5 · HEPÁTICO: ASCITIS

Cirrosis F11
menos albúmina, hipertensión portal e hiperaldosteronismo secundario

por menos albúmina y portal da → Ascitis; la proteinuria > 3,5 g no interviene F11

6 · RENAL: NEFRÓTICO Y NEFRÍTICO

Síndrome nefrótico F12 · F18
proteinuria > 3,5 g/24 h, hipoproteinemia, hiperlipidemia

se distingue del → **Nefrítico** F12
edema discreto (2-3 cruces) con hipertensión y hematuria; retiene sodio y agua

por pérdida de proteínas causa → **Hipoalbuminemia** F1 · F16 · F18
cae la oncótica; baja el volumen plasmático y se activa el SRAA

y se manifiesta como → Anasarca matutina y facial, que se extiende a miembros y cavidades F13

explica el → **Edema carencial** F16
albúmina menor de 2 g/100 ml (ingesta, pérdida renal, cirrosis)

7 · OTROS EDEMAS Y COMPLICACIÓN

en el nefrítico contribuye al

Premenstrual F3
exceso de estrógenos antes de la regla

en el miembro paralizado actúa en

Tromboembolia pulmonar F17
si el trombo se suelta: disnea súbita, dolor torácico y hemoptisis

Mixedema F14
elástico, sin fóvea, por mucopolisacáridos en el intersticio

Hemiplejía F15
atrofia muscular, estasis y posición del miembro; no hay proteinuria

concepto · desenlace · ejemplo · mecanismo · causa · borde dorado = alto rendimiento · F# = pregunta n.º # de la lámina

Fuente: Clase 2 · Dr. Sotito — teoría del docente (= literatura)